FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
FIOCRUZ BRASÍLIA
COLABORATÓRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SOCIEDADE (CTIS)

WAGNER DE JESUS MARTINS
FERNANDA MACHINER
MARIA EDUARDA SILVA
JEFERSON MARTINS DE CASTRO

VIGILÂNCIA POPULAR E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA TERRITORIAL EM SAÚDE:

estudo qualitativo longitudinal da implementação da metodologia PICAPS no Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal



BRASÍLIA
2026

PICAPS
FIOCRUZ | Brasília
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

WAGNER DE JESUS MARTINS
FERNANDA MACHINER
MARIA EDUARDA SILVA
JEFERSON MARTINS DE CASTRO

VIGILÂNCIA POPULAR E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA TERRITORIAL EM SAÚDE:

estudo qualitativo longitudinal da implementação da metodologia PICAPS no Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal

Projeto de pesquisa apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz Brasília, por meio da Plataforma Brasil, e a [agência ou edital de financiamento], desenvolvido pelo CoLaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade (CTIS) da Fiocruz Brasília em parceria com a Universidade de Brasília e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Equipe: [nomes, instituições e funções; links do Currículo Lattes].

BRASÍLIA
2026

RESUMO

Metodologias participativas de vigilância em saúde são promovidas como forma de aproximar o conhecimento produzido nos territórios das respostas dos serviços, mas pouco se sabe sobre o que acontece com esse conhecimento depois de registrado. Este projeto analisa como, para quem e em que condições a metodologia de governança participativa territorial da Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS) transforma conhecimentos produzidos no território em deliberação coletiva e em respostas dos serviços de Atenção Primária à Saúde e de Vigilância em Saúde. A metodologia ativa redes sociotécnicas, produz com elas a cartografia social e o Plano Popular, forma pesquisadores populares e institui Salas de Cooperação Social, nas quais esses pesquisadores atuam na vigilância popular e na articulação do Plano Popular. Trata-se de estudo de caso qualitativo longitudinal, com quatro setores do Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal, como unidades incorporadas, conduzido como avaliação de processo informada pela abordagem realista. Em três ondas ancoradas nos marcos da intervenção, serão realizadas cerca de 100 entrevistas com 44 participantes, observação de reuniões e oficinas, análise documental, rastreamento de 24 trajetórias de alertas e demandas e oito oficinas de interpretação com os participantes. A análise seguirá o método framework, com análise transversal recorrente e de trajetórias, e refinará uma teoria inicial do programa em configurações contexto–mecanismo–resultado. A independência analítica será assegurada pela separação entre a equipe de campo e a equipe de implementação e por revisão externa. Espera-se produzir uma teoria do programa sustentada empiricamente, uma tipologia das trajetórias entre comunidade e serviços e recomendações para a articulação entre Salas e serviços de saúde.

Palavras-chave: vigilância popular em saúde; participação social; Atenção Primária à Saúde; pesquisa qualitativa; avaliação de processos em cuidados de saúde.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Teoria inicial do programa: configurações contexto–mecanismo–resultado..... 13
Quadro 2 – Participantes, critérios de inclusão e estimativas de entrevistas..... 15
Quadro 3 – Ondas de produção de dados por setor (meses do projeto)..... 16
Quadro 4 – Critérios de rigor e procedimentos correspondentes..... 17
Quadro 5 – Matriz de consistência do estudo..... 18
Quadro 6 – Cronograma de execução por semestre..... 23
Quadro 7 – Orçamento estimado..... 24

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APS	Atenção Primária à Saúde
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CTIS	CoLaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade
DPT	Diálogos Prospectivos Territoriais
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz
IVT+A	Índice de Vulnerabilidade Territorial Ampliado
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MTEI	Matriz de Tradução Epistêmica Intercultural
PDAD-A	Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada
PICAPS	Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde
SCS	Sala de Cooperação Social
SES-DF	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
SUS	Sistema Único de Saúde
TIDieR	Template for Intervention Description and Replication
UBS	Unidade Básica de Saúde
UnB	Universidade de Brasília

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7

2 JUSTIFICATIVA 8

3 PROBLEMA, QUESTÕES E PRESSUPOSTOS 9
- 3.1 PROBLEMA DE PESQUISA 9
- 3.2 OBJETO 9
- 3.3 PERGUNTA CENTRAL 9
- 3.4 QUESTÕES ESPECÍFICAS 9
- 3.5 PRESSUPOSTOS ORIENTADORES 10

4 OBJETIVOS 11
- 4.1 OBJETIVO GERAL 11
- 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11

5 REFERENCIAL TEÓRICO 12
- 5.1 DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E TERRITÓRIO USADO 12
- 5.2 VIGILÂNCIA POPULAR, EDUCAÇÃO POPULAR E COPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 12
- 5.3 REDES SOCIOTÉCNICAS, TRADUÇÃO E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA 12
- 5.4 AVALIAÇÃO DE PROCESSO E ABORDAGEM REALISTA 13

6 METODOLOGIA 14
- 6.1 TIPO DE ESTUDO E DESENHO 14
- 6.2 A INTERVENÇÃO ESTUDADA 14
- 6.3 CENÁRIO, CASO E UNIDADES DE ANÁLISE 15
- 6.4 PARTICIPANTES E AMOSTRAGEM 15
- 6.5 ONDAS LONGITUDINAIS E PRODUÇÃO DE DADOS 16
- 6.6 ANÁLISE DOS DADOS 16
- 6.7 RIGOR, REFLEXIVIDADE E INDEPENDÊNCIA ANALÍTICA 17
- 6.8 MATRIZ DE CONSISTÊNCIA 18
- 6.9 DADOS SECUNDÁRIOS DE CONTEXTO 18

7 ASPECTOS ÉTICOS 19
- 7.1 MARCO NORMATIVO E TRAMITAÇÃO 19
- 7.2 CONSENTIMENTO 19
- 7.3 RISCOS E BENEFÍCIOS 19
- 7.4 PROTEÇÃO DE DADOS 20
- 7.5 DEVOLUTIVA E GOVERNANÇA COMUNITÁRIA 20

8 LIMITAÇÕES 21

9 RESULTADOS ESPERADOS E PRODUTOS 22

10 CRONOGRAMA 23

11 RECURSOS E ORÇAMENTO 24

REFERÊNCIAS 25

APÊNDICE A – ROTEIRO-BASE DE ENTREVISTA COM PESQUISADORES POPULARES 28

APÊNDICE B – GUIA DE OBSERVAÇÃO DAS REUNIÕES DAS SALAS DE COOPERAÇÃO SOCIAL 29

APÊNDICE C – FICHA DE RASTREAMENTO DE TRAJETÓRIA 30

1 INTRODUÇÃO

A saúde de uma população é produzida pelas condições materiais e pelas relações sociais que se inscrevem no território, e não se distribui ao acaso no espaço urbano (LAURELL, 1982; BREILH, 2006; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou essa concepção ampliada em seu marco constitucional e legal (BRASIL, 1988; 1990) e organizou a Atenção Primária à Saúde (APS) com base territorial. Ainda assim, os sistemas de informação e as rotinas dos serviços nem sempre reconhecem, com oportunidade e granularidade suficientes, os problemas que os moradores percebem no cotidiano, sobretudo nas periferias urbanas, onde a distância entre o território vivido e o território registrado tende a ser maior (PAIM, 2018).

A vigilância popular em saúde tem sido proposta como forma de aproximar essas duas realidades, ao reconhecer moradores e organizações comunitárias como produtores legítimos de conhecimento sobre o próprio território (MACHADO et al., 2024; OLIVEIRA et al., 2024). Sua contribuição, contudo, não pode ser presumida. Ela depende da qualidade dos registros, da segurança de quem observa, da disposição e da capacidade dos serviços de responder e das condições que permitem sustentar a participação ao longo do tempo. Experiências participativas também podem reproduzir assimetrias de voz, sobrecarregar lideranças e gerar expectativas que as instituições não atendem (TRAD; ESPERIDIÃO, 2009).

A Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS), desenvolvida pelo CoLaboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade (CTIS) da Fiocruz Brasília em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), opera desde 2020 em territórios do Distrito Federal (MARTINS et al., 2024; SELLERA et al., 2019). Sua metodologia de governança participativa territorial organiza-se em seis etapas encadeadas: a ativação das redes sociotécnicas do território; o diagnóstico multidimensional e a cartografia social realizados com essa rede, segundo os Diálogos Prospectivos Territoriais (DPT); a elaboração do Plano Popular; a formação de pesquisadores populares entre os participantes da cartografia; e a instalação das Salas de Cooperação Social (SCS), nas quais esses pesquisadores atuam na vigilância popular em saúde e na defesa, promoção e articulação para a efetivação do Plano Popular (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026a; 2026b).

Este projeto propõe um estudo qualitativo longitudinal da implementação dessa metodologia no Sol Nascente/Pôr do Sol (Região Administrativa XXXII), durante o seu primeiro ciclo de implantação. O foco não é estimar o efeito da intervenção sobre indicadores de saúde, objetivo para o qual o desenho de um único território e o horizonte de 36 meses seriam insuficientes. O foco é compreender **como, para quem e em que condições** a metodologia transforma conhecimentos produzidos no território em deliberação coletiva e em respostas dos serviços de saúde, e por que, em outras situações, isso não acontece.

O documento está organizado em onze seções. Após esta introdução, apresentam-se a justificativa (seção 2), o problema, as questões e os pressupostos (seção 3), os objetivos (seção 4) e o referencial teórico, que culmina na teoria inicial do programa (seção 5). A seção 6 detalha a metodologia; a seção 7, os aspectos éticos; a seção 8, as limitações; a seção 9, os resultados esperados; e as seções 10 e 11, o cronograma e os recursos.

2 JUSTIFICATIVA

A justificativa do estudo assenta-se em três argumentos: uma lacuna de conhecimento, uma necessidade avaliativa da própria intervenção e uma demanda de gestão.

O primeiro argumento é a **lacuna de conhecimento**. A literatura brasileira sobre vigilância popular descreve experiências e fundamenta o conceito (MACHADO et al., 2024; OLIVEIRA et al., 2024), mas são escassos os estudos que acompanham longitudinalmente o que acontece com a informação produzida pela comunidade depois que ela é registrada: por onde circula, como é traduzida para a linguagem dos serviços, quem a valida, quando produz resposta e quando se perde. Essa trajetória é justamente o elo do qual depende qualquer efeito sobre a saúde, e é o elo menos estudado.

O segundo argumento é **avaliativo**. O referencial do Medical Research Council para intervenções complexas recomenda que a estimação de efeitos seja precedida, ou acompanhada, por uma avaliação de processo capaz de descrever a implementação, os mecanismos e o contexto (MOORE et al., 2015; SKIVINGTON et al., 2021). Sem esse conhecimento, um eventual estudo de efeito não saberia o que está avaliando, nem por que a intervenção funciona ou falha. A PICAPS acumula seis anos de operação, mas sua teoria do programa ainda não foi explicitada nem confrontada sistematicamente com dados empíricos.

O terceiro argumento é a **demanda de gestão**. A SES-DF e as equipes de APS precisam saber em que condições os alertas e as demandas oriundos das Salas de Cooperação Social podem ser incorporados às rotinas sem sobrecarregar os serviços, e que arranjos institucionais tornam essa articulação sustentável. O estudo produzirá recomendações diretamente aplicáveis a esse problema.

O Sol Nascente/Pôr do Sol foi escolhido por combinar alta vulnerabilidade e escala compatível com a implantação faseada da metodologia. Segundo o diagnóstico situacional elaborado pela PICAPS a partir da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (PDAD-A 2024), o território tem cerca de 108,7 mil habitantes, a segunda menor renda domiciliar per capita do Distrito Federal (R$ 846) e a maior proporção de domicílios em ruas que alagam (66%) (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026c). Esses números serão conferidos nas fontes primárias antes da submissão, com ano, recorte territorial e método explicitados. Sua função aqui é apenas situar o caso, não fundamentar inferências.

3 PROBLEMA, QUESTÕES E PRESSUPOSTOS

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Não se sabe como, para quem e em que condições uma metodologia de governança participativa territorial consegue transformar conhecimentos produzidos pela comunidade em deliberação coletiva legítima e em respostas efetivas dos serviços de APS e de Vigilância em Saúde, nem quais mecanismos explicam os casos em que essa transformação ocorre e aqueles em que fracassa.

3.2 OBJETO

O objeto é o processo de implementação da metodologia de governança participativa territorial da PICAPS no Sol Nascente/Pôr do Sol, observado em seus quatro setores (Trechos 1, 2 e 3 e Pôr do Sol), da ativação das redes sociotécnicas à operação das Salas de Cooperação Social, com ênfase nas trajetórias que ligam o conhecimento comunitário à resposta institucional.

3.3 PERGUNTA CENTRAL

Como, para quem e em que condições a metodologia de governança participativa territorial da PICAPS transforma conhecimentos produzidos no território em deliberação coletiva e em respostas dos serviços de saúde no Sol Nascente/Pôr do Sol?

3.4 QUESTÕES ESPECÍFICAS

A pergunta central desdobra-se em cinco questões, cada uma correspondente a um objetivo específico (seção 4) e articulada a fontes e procedimentos analíticos na matriz de consistência (Quadro 5):

a) Q1 – como as redes sociotécnicas são ativadas e quem delas participa, permanece, se afasta ou fica de fora do processo, inclusive da formação de pesquisadores populares;

b) Q2 – como problemas de saúde são identificados, registrados, validados e priorizados na cartografia social, no Plano Popular e na vigilância popular, e onde os saberes comunitários e institucionais convergem ou divergem;

c) Q3 – que trajetórias percorrem os alertas da vigilância popular e as demandas do Plano Popular até a resposta, a recusa ou a ausência de resposta dos serviços e da gestão, e o que explica essas diferenças;

d) Q4 – como as Salas de Cooperação Social se constituem como espaços de governança participativa, quem delibera, com que legitimidade e com que relações de poder, e como isso muda ao longo do tempo;

e) Q5 – em que contextos e por quais mecanismos a metodologia produz, ou deixa de produzir, os resultados esperados, e que efeitos não previstos ou adversos emergem.

3.5 PRESSUPOSTOS ORIENTADORES

Em lugar de hipóteses a testar, o estudo adota pressupostos sensibilizadores, que orientam a atenção do campo sem predeterminar os achados e serão ativamente confrontados com casos divergentes:

a) P1 – **pluralidade epistêmica**: registros comunitários e institucionais expressam formas distintas de observar, classificar e priorizar problemas, e nenhuma delas será tratada a priori como padrão de verdade (FUNTOWICZ; RAVETZ, 1993);

b) P2 – **tradução**: a informação comunitária só produz resposta quando é traduzida para categorias, canais e atribuições que os serviços reconhecem, e essa tradução depende de mediadores e de objetos-fronteira (CALLON, 1986; STAR; GRIESEMER, 1989);

c) P3 – **participação desigual**: espaços participativos podem ampliar vozes antes ausentes e, ao mesmo tempo, reproduzir assimetrias de representação e influência (TRAD; ESPERIDIÃO, 2009);

d) P4 – **contingência**: os resultados dependem do contexto, da continuidade das equipes, dos recursos e de acontecimentos externos, e incluem efeitos nulos, contraditórios e adversos, como demandas registradas que nunca recebem resposta.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Analisar como, para quem e em que condições a metodologia de governança participativa territorial da PICAPS é implementada e transforma conhecimentos produzidos no território em deliberação coletiva e em respostas dos serviços de Atenção Primária à Saúde e de Vigilância em Saúde, no Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal, ao longo de seu primeiro ciclo de implantação.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) analisar a ativação das redes sociotécnicas e a constituição do grupo de pesquisadores populares, identificando quem participa, permanece, se afasta ou fica de fora, e por quê (Q1);

b) compreender como problemas de saúde são identificados, registrados, validados e priorizados por atores comunitários e institucionais, examinando convergências e divergências entre seus saberes (Q2);

c) reconstruir as trajetórias de alertas da vigilância popular e de demandas do Plano Popular até a resposta, a recusa ou a ausência de resposta, identificando as condições que explicam cada desfecho (Q3);

d) analisar a constituição e a transformação das Salas de Cooperação Social como espaços de governança participativa, considerando deliberação, legitimidade e relações de poder (Q4);

e) refinar a teoria do programa da metodologia, explicitando configurações de contexto, mecanismo e resultado que expliquem resultados esperados, não esperados e adversos (Q5).

5 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial organiza-se em três níveis com funções distintas: uma teoria do problema, que explica por que a vulnerabilidade é territorial e socialmente produzida; uma teoria da intervenção, que explica como a metodologia pretende agir; e uma perspectiva avaliativa, que define como a pesquisa vai examiná-la. A seção termina com a teoria inicial do programa, que é o ponto de partida da análise.

5.1 DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E TERRITÓRIO USADO

A epidemiologia crítica latino-americana compreende o processo saúde-doença como expressão das formas de vida coletivas e das relações de produção e reprodução social (LAURELL, 1982; BREILH, 2006). No Brasil, essa perspectiva sustentou a Reforma Sanitária e a concepção ampliada de saúde do SUS (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; PAIM, 2018). Para apreendê-la empiricamente, o estudo adota a categoria de território usado de Milton Santos (2002): o espaço como unidade entre a materialidade e as ações de quem o habita, atravessado por verticalidades, que impõem lógicas externas, e por horizontalidades, as solidariedades e redes construídas localmente. A vulnerabilidade será tratada como processo histórico e espacialmente desigual, e não como atributo das comunidades.

5.2 VIGILÂNCIA POPULAR, EDUCAÇÃO POPULAR E COPRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

A vigilância popular em saúde distingue-se da vigilância institucional por reconhecer os moradores como sujeitos da observação, da interpretação e da ação sobre o território, e não como fontes de dados (MACHADO et al., 2024; OLIVEIRA et al., 2024). Seu fundamento pedagógico está na educação popular de Paulo Freire (1987), que concebe o conhecimento como produção dialógica a partir da leitura do mundo, e na investigação-ação participativa de Fals Borda (1985), que articula investigação, educação e ação. A noção de comunidade de pares estendida, da ciência pós-normal, legitima a ampliação dos produtores de conhecimento em situações de alta incerteza e valores em disputa (FUNTOWICZ; RAVETZ, 1993).

Esse referencial impõe à pesquisa uma exigência e um cuidado. A exigência é tratar o conhecimento comunitário como conhecimento, e não como opinião a ser validada pela ciência. O cuidado é não converter participação em sinônimo de emancipação: a análise examinará quem fala, quem é ouvido, quem decide e quem paga o custo da participação.

5.3 REDES SOCIOTÉCNICAS, TRADUÇÃO E GOVERNANÇA PARTICIPATIVA

A metodologia da PICAPS começa pela ativação de redes sociotécnicas. A teoria dos laços fracos explica por que atores-ponte entre grupos são decisivos para a circulação de informação nova (GRANOVETTER, 1973). A sociologia da tradução descreve como um conjunto heterogêneo de atores passa a agir em conjunto quando seus interesses são problematizados, negociados e alinhados, e como essa rede pode se desfazer quando os porta-vozes perdem legitimidade (CALLON, 1986). A cartografia social e o Plano Popular podem ser lidos como objetos-fronteira: artefatos suficientemente estáveis para circular entre moradores, profissionais e gestores, e suficientemente flexíveis para serem interpretados por cada um segundo suas necessidades (STAR; GRIESEMER, 1989).

A governança participativa, por fim, é entendida como a capacidade de um espaço coletivo de deliberar e de influenciar decisões que não controla diretamente (TRAD; ESPERIDIÃO, 2009). Nas Salas de Cooperação Social, essa capacidade se expressa em duas funções: a vigilância popular, que produz e encaminha alertas, e a articulação do Plano Popular, que leva as prioridades do território às instâncias de decisão, segundo a lógica do planejamento estratégico situacional (MATUS, 1987; FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026b).

5.4 AVALIAÇÃO DE PROCESSO E ABORDAGEM REALISTA

A perspectiva avaliativa combina duas tradições. A avaliação de processo de intervenções complexas examina a implementação (o que foi feito, com que fidelidade e com que adaptações), os mecanismos de impacto (como os participantes respondem à intervenção) e o contexto (o que facilita ou impede o funcionamento) (MOORE et al., 2015). A avaliação realista acrescenta uma forma de explicar: os programas não produzem resultados por si, mas oferecem recursos que desencadeiam mecanismos, isto é, raciocínios e respostas das pessoas, que só operam em determinados contextos; a explicação toma a forma de configurações contexto–mecanismo–resultado (PAWSON; TILLEY, 1997).

A adoção dessa abordagem tem uma consequência prática: o estudo parte de uma teoria inicial do programa, formulada a partir dos documentos da PICAPS e da literatura, e a revisa sistematicamente com os dados de campo. A teoria inicial não é uma hipótese a confirmar, mas um conjunto de proposições explicitamente refutáveis. O Quadro 1 apresenta essa teoria, incluindo explicações rivais.

Quadro 1 – Teoria inicial do programa: configurações contexto-mecanismo-resultado

Etapa	Contexto (C)	Mecanismo (M)	Resultado esperado (R)	Explicação rival
Ativação da rede	Organizações comunitárias ativas e lideranças-ponte entre grupos	Reconhecimento e confiança: os atores percebem o processo como seu	Adesão à cartografia de grupo diverso	Captura por lideranças já dominantes; exclusão de grupos sem organização
Cartografia e Plano Popular	Escuta efetiva e tradução de saberes (MTEI e Matriz UIC)	Sentido de autoria coletiva	Plano reconhecido como legítimo pelos moradores	Plano percebido como produto técnico da equipe externa
Formação dos pesquisadores populares	Formação dialógica com o mesmo grupo da cartografia	Autoeficácia e identidade de pesquisador popular	Permanência e atuação regular	Sobrecarga, ausência de remuneração e desistência
Vigilância popular	Fluxo pactuado com a UBS e interlocutor nomeado no serviço	Credibilidade mútua: o serviço reconhece o alerta; o pesquisador percebe retorno	Resposta documentada e continuidade dos registros	Ausência de retorno gera descrédito e abandono dos registros
Articulação do Plano Popular	Acesso a decisores e janelas de oportunidade	Legitimidade política da Sala como porta-voz do território	Ações do Plano incorporadas à agenda da gestão	Cooptação ou conflito com a gestão; retaliação a lideranças

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em FIOCRUZ BRASÍLIA (2026a; 2026b) e Pawson e Tilley (1997).

6 METODOLOGIA

6.1 TIPO DE ESTUDO E DESENHO

Trata-se de um **estudo de caso qualitativo longitudinal, com unidades de análise incorporadas** (YIN, 2015), conduzido como **avaliação de processo informada pela abordagem realista** (MOORE et al., 2015; PAWSON; TILLEY, 1997) e com **componente participativo** nos ciclos de interpretação e devolutiva (THIOLLENT, 2011). O caso é a implementação da metodologia no Sol Nascente/Pôr do Sol; as unidades incorporadas são os quatro setores, cada um com sua rede ativada, seu Plano Popular e sua Sala de Cooperação Social. A dimensão longitudinal consiste em acompanhar os mesmos participantes, espaços e episódios em três ondas de produção de dados, ancoradas nos marcos da intervenção em cada setor, o que permite analisar mudanças e trajetórias, e não apenas retratos sucessivos (SALDAÑA, 2003; NEALE, 2019).

Duas escolhas de desenho precisam ser explicitadas. A primeira refere-se à pesquisa-ação. A ação estudada, isto é, a implantação da metodologia, é conduzida pelo CTIS e pelos atores do território, e não pela equipe de pesquisa. Por isso, o estudo não se define como pesquisa-ação em sentido estrito. O componente participativo está nas oficinas de interpretação, em que achados parciais retornam às Salas e podem reorientar a implementação. Essas reorientações não são tratadas como viés a eliminar: são registradas em um diário de efeitos da pesquisa sobre a intervenção e analisadas como parte do objeto.

A segunda escolha refere-se à comparação externa. Versões anteriores do projeto previam um território-espelho. Num desenho qualitativo, um território sem intervenção não oferece trajetórias a reconstruir nem Salas a observar, e sua inclusão imporia custos éticos e logísticos sem ganho analítico. Ele foi, portanto, **excluído**. A comparação analítica ocorre entre os quatro setores, que entram na intervenção em momentos diferentes e tendem a apresentar contextos distintos, e entre episódios com desfechos contrastantes.

6.2 A INTERVENÇÃO ESTUDADA

A intervenção será descrita segundo o checklist TIDieR (HOFFMANN et al., 2014), a partir do Manual Técnico-Operacional dos DPT (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026a) e do Protocolo de Inteligência Territorial (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026b). Suas seis etapas são implantadas integralmente em cada setor, em ordem definida por sorteio e em degraus trimestrais, conforme o planejamento da PICAPS:

a) **Etapa 1** – ativação das redes sociotécnicas do setor, por mapeamento sociométrico de movimentos sociais, lideranças e coletivos, com pacto dialógico;

b) **Etapa 2** – diagnóstico multidimensional segundo as cinco dimensões dos DPT, realizado com a rede ativada;

c) **Etapa 3** – cartografia social participativa, tendo a rede ativada como público-base;

d) **Etapa 4** – elaboração e pactuação do Plano Popular;

e) **Etapa 5** – formação dos pesquisadores populares, recrutados entre os participantes da cartografia;

f) **Etapa 6** – instalação e operação da Sala de Cooperação Social, na qual os pesquisadores populares exercem a vigilância popular em saúde e a defesa, promoção e articulação para a efetivação do Plano Popular.

Antes do início do campo, será elaborado um guia descritivo dos componentes, que registra o que foi previsto e permite documentar o que efetivamente ocorreu. Será distinguida a implantação formal de cada componente de seu funcionamento efetivo, e adaptações, interrupções e controvérsias serão registradas com suas justificativas.

6.3 CENÁRIO, CASO E UNIDADES DE ANÁLISE

O cenário é o Sol Nascente/Pôr do Sol, na Região de Saúde Oeste do Distrito Federal. Os quatro setores serão acompanhados com o mesmo protocolo, mas com intensidade diferente de observação. Os dois primeiros setores na ordem de implantação, que terão o maior tempo de operação da Sala dentro do horizonte do estudo (cerca de 21 e 18 meses), receberão **acompanhamento intensivo**, com observação de todas as reuniões deliberativas. Os outros dois receberão **acompanhamento extensivo**, com observação de uma a cada duas reuniões. Essa decisão privilegia a fase de consolidação, que só pode ser observada onde a Sala opera por mais tempo, sem abandonar a variação entre setores.

6.4 PARTICIPANTES E AMOSTRAGEM

A amostragem será intencional, orientada pela relevância analítica e pela diversidade, e não pela representatividade estatística. O tamanho previsto foi estimado pelo critério de poder informacional, que considera a especificidade do objetivo, a densidade dos participantes em relação à pergunta, o uso de teoria, a qualidade do diálogo e a estratégia de análise (MALTERUD; SIERSMA; GUASSORA, 2016). Por se tratar de estudo longitudinal com várias fontes por episódio, o poder informacional cresce com o acompanhamento repetido dos mesmos participantes, o que justifica painéis menores com várias entrevistas por pessoa. O Quadro 2 apresenta as estimativas, que serão revistas ao longo do campo com justificativa registrada.

Quadro 2 – Participantes, critérios de inclusão e estimativas de entrevistas

Grupo	Critérios de inclusão	Pessoas	Ondas	Entrevistas
Pesquisadores populares (painel)	Formados na Etapa 5; 18 anos ou mais; diversidade de gênero, idade, trajetória de militância e intensidade de atuação	12 (3 por setor)	01, 02, 03	36
Rede ativada que não se tornou pesquisador popular, lideranças e moradores	18 anos ou mais; inclui quem se afastou, críticos e pessoas pouco envolvidas	12 (3 por setor)	01, 03	24
Profissionais de APS e de Vigilância em Saúde	Atuação nas equipes de Saúde da Família ou na vigilância de referência do setor	12 (3 por setor)	02, 03	24
Gestores da SES-DF e da Região de Saúde Oeste	Responsabilidade sobre a APS ou a vigilância do território	4	02, 03	8
Equipe de implementação do CTIS	Facilitadores e supervisores da metodologia nos setores	4	02, 03	8
Total estimado		44		100

Fonte: Elaboração própria (2026).

Além do painel, serão realizadas entrevistas de saída com pesquisadores populares que deixarem a função, porque o afastamento é informação central sobre a sustentabilidade da metodologia. Não serão incluídos menores de 18 anos como participantes da pesquisa. A recusa ou a desistência não acarretará qualquer prejuízo no acesso a serviços, na participação nas atividades da PICAPS ou nas relações de trabalho.

6.5 ONDAS LONGITUDINAIS E PRODUÇÃO DE DADOS

As ondas são definidas por marcos da intervenção, e não por datas fixas, para que os setores sejam comparados em momentos equivalentes de sua trajetória. O Quadro 3 apresenta o calendário previsto, que acompanhará eventuais ajustes no cronograma da implantação.

Quadro 3 – Ondas de produção de dados por setor (meses do projeto)

Setor (ordem de implantação)	Onda 1 – ativação e cartografia (Etapas 1 a 3)	Onda 2 – início da Sala (1 a 3 meses de operação)	Onda 3 – consolidação (9 a 12 meses de operação)
1º setor (intensivo)	M7–M9	M13–M15	M22–M24
2º setor (intensivo)	M10–M12	M16–M18	M25–M27
3º setor (extensivo)	M13–M15	M19–M21	M28–M30
4º setor (extensivo)	M16–M18	M22–M24	M31–M33

Fonte: Elaboração própria (2026), com base no calendário de implantação faseada da PICAPS.

Serão empregados cinco procedimentos de produção de dados:

a) entrevistas semiestruturadas, com roteiros específicos por grupo e por onda (Apêndice A), gravadas em áudio mediante consentimento e transcritas na íntegra; na segunda e na terceira ondas, os roteiros retomam o que o participante relatou anteriormente, para explorar mudanças;

b) observação participante das reuniões deliberativas das Salas, das oficinas de cartografia social e de elaboração do Plano Popular (ao menos duas por setor) e de encontros da formação (dois por turma), registrada em diário de campo com roteiro padronizado (Apêndice B); estimam-se cerca de 52 reuniões de Sala observadas;

c) análise documental de atas, Relatórios de Ciclo, Planos Populares, mapas da cartografia social, materiais formativos, registros agregados de alertas e encaminhamentos da Plataforma Ágora e documentos institucionais da SES-DF;

d) rastreamento de trajetórias: reconstrução de 24 episódios (seis por setor), selecionados de forma estratificada entre alertas da vigilância popular e demandas do Plano Popular, garantindo que ao menos um terço deles não tenha recebido resposta; cada episódio é reconstruído por documentos e por entrevistas curtas com os atores envolvidos, em ficha própria (Apêndice C);

e) oficinas de interpretação com cada Sala após a segunda e a terceira ondas (oito no total), nas quais achados parciais são discutidos com os participantes.

6.6 ANÁLISE DOS DADOS

A análise será conduzida pelo *método* framework** *(GALE et al., 2013), adequado a estudos com várias fontes, várias unidades de caso e questões previamente definidas, porque permite comparar casos e temas sem perder o contexto de cada relato. O método segue cinco passos: familiarização com o material;*

codificação inicial, que combina códigos derivados da teoria do programa (Quadro 1) com códigos indutivos; construção do quadro analítico; indexação de todo o corpus; e organização dos dados em matrizes. As matrizes cruzam participantes ou episódios (linhas) com temas (colunas), em cada onda, e serão mantidas no software* MAXQDA.

A dimensão temporal será analisada por duas estratégias complementares (GROSSOEHME; LIPSTEIN, 2016): a análise **transversal recorrente**, que compara os temas entre as ondas para identificar o que muda no conjunto; e a análise de **trajetórias**, que acompanha cada participante e cada episódio ao longo do tempo para identificar como e por que suas posições mudam. As perguntas de Saldaña (2003) sobre o que aumenta, diminui, surge, cessa ou permanece orientarão essa leitura.

Para responder à questão dos mecanismos (Q5), as matrizes serão usadas para formular e testar configurações contexto–mecanismo–resultado, por raciocínio retrodutivo: a partir de um resultado observado, pergunta-se que mecanismo o explicaria e em que contexto ele operou, confrontando a explicação com as rivais do Quadro 1 e com casos negativos (PAWSON; TILLEY, 1997). A teoria inicial será revista ao final de cada onda, e cada revisão será documentada com as evidências que a motivaram.

Dois pesquisadores codificarão de forma independente cerca de 20% do material da primeira onda, para calibrar o quadro analítico. As divergências serão discutidas até a definição consensual dos códigos. O objetivo dessa dupla codificação é refinar categorias e expor pressupostos, e não calcular coeficientes de concordância, que não são compatíveis com a lógica interpretativa da análise.

6.7 RIGOR, REFLEXIVIDADE E INDEPENDÊNCIA ANALÍTICA

O rigor será assegurado pelos critérios de confiabilidade da pesquisa qualitativa (LINCOLN; GUBA, 1985), operacionalizados conforme o Quadro 4. O relato seguirá os padrões SRQR (O'BRIEN et al., 2014) e, para entrevistas, o COREQ (TONG; SAINSBURY; CRAIG, 2007).

Quadro 4 – Critérios de rigor e procedimentos correspondentes

Critério	Procedimentos
Credibilidade	Permanência prolongada no campo; triangulação de entrevistas, observação, documentos e trajetórias; busca ativa de casos negativos; oficinas de interpretação com os participantes
Transferibilidade	Descrição densa do território, dos setores e da intervenção (TIDieR); explicitação dos critérios de seleção de participantes e episódios
Dependabilidade	Protocolo e roteiros versionados; registro de todas as alterações no quadro analítico; trilha de auditoria revisada por analista externo à implementação
Confirmabilidade	Diários reflexivos da equipe; separação entre equipe de campo e equipe de implementação; apresentação de evidência empírica para cada interpretação

Fonte: Elaboração própria (2026).

A independência analítica é o ponto mais sensível do estudo, porque o CTIS concebe e implementa a metodologia. Para enfrentá-lo, adotam-se três regras. A primeira é a **separação de equipes**: as entrevistas, a observação e a codificação serão realizadas por pesquisadores vinculados à UnB, sem função na implementação; a equipe do CTIS participa do desenho e das discussões interpretativas, mas não entrevista pesquisadores populares nem profissionais e não tem acesso a dados identificados. A segunda é a **revisão externa**: um analista sem vínculo com a PICAPS revisará a trilha de auditoria e as interpretações ao final de cada onda, mediante termo de compromisso a ser firmado antes do início do

campo. A terceira é a **ausência de veto**: as devolutivas servem para corrigir erros factuais e registrar divergências, mas nenhum participante ou instituição poderá vetar achados críticos ou desfavoráveis.

6.8 MATRIZ DE CONSISTÊNCIA

O Quadro 5 articula cada questão de pesquisa ao objetivo, às fontes e à estratégia de análise correspondentes.

Quadro 5 – Matriz de consistência do estudo

Questão	Objetivo	Fontes principais	Estratégia de análise
Q1 – ativação da rede e constituição do grupo	OE1	Entrevistas com rede, pesquisadores populares e equipe; entrevistas de saída; mapas sociométricos; observação das Etapas 1 a 5	Matrizes por setor e onda; trajetórias de participação
Q2 – identificação e priorização de problemas	OE2	Observação da cartografia e do Plano; documentos; entrevistas com pesquisadores populares e profissionais	Comparação entre categorias comunitárias e institucionais; análise transversal recorrente
Q3 – trajetórias de alertas e demandas	OE3	Rastreamento de 24 episódios; registros da Plataforma Ágora; entrevistas com profissionais e gestores	Reconstrução de episódios; comparação entre episódios com e sem resposta
Q4 – governança nas Salas	OE4	Observação das reuniões; atas e Relatórios de Ciclo; entrevistas de todos os grupos	Análise de trajetórias da Sala; relações de poder e legitimidade
Q5 – mecanismos e efeitos não previstos	OE5	Todas as fontes; oficinas de interpretação; diário de efeitos da pesquisa	Configurações contexto–mecanismo–resultado por retrodução; teste de explicações rivais

Fonte: Elaboração própria (2026).

6.9 DADOS SECUNDÁRIOS DE CONTEXTO

Indicadores de saúde e de condições de vida do território (por exemplo, internações por condições sensíveis à APS, captação precoce de gestantes e indicadores socioambientais) serão usados apenas para descrever o contexto e para formular perguntas ao campo. Não serão interpretados como medida de efeito da metodologia. Do mesmo modo, o Índice de Vulnerabilidade Territorial Ampliado (IVT+A) não é desfecho deste estudo. Se o índice for calculado pela PICAPS, a pesquisa examinará como ele é produzido e usado nas Salas, com atenção ao risco de circularidade: quando componentes do índice derivam de atividades da própria intervenção, como reuniões ou alertas, sua variação pode refletir maior registro, e não menor vulnerabilidade.

7 ASPECTOS ÉTICOS

7.1 MARCO NORMATIVO E TRAMITAÇÃO

O protocolo será submetido pela Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz Brasília, como instituição proponente, com a SES-DF e a UnB como instituições coparticipantes. A pesquisa observará a Lei nº 14.874/2024 e o Decreto nº 12.651/2025, que instituem o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (BRASIL, 2024; 2025), e a Resolução CNS nº 510/2016, aplicável às pesquisas com metodologias próprias das Ciências Humanas e Sociais (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2016), complementada pela Resolução CNS nº 466/2012 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012), que permanecem válidas no que não contrariarem a nova legislação. Nenhuma atividade de produção de dados com participantes será iniciada antes da aprovação ética.

7.2 CONSENTIMENTO

O consentimento livre e esclarecido será obtido de cada participante entrevistado, com registro escrito ou, quando a escrita for inadequada à situação do participante, em áudio, nos termos da Resolução CNS nº 510/2016, sempre com entrega de documento com as informações da pesquisa. Na observação das reuniões das Salas, a pesquisa será apresentada ao coletivo, que deliberará sobre a presença do pesquisador; qualquer pessoa poderá pedir que suas falas não sejam registradas no diário de campo. As reuniões não serão gravadas em áudio ou vídeo. No acompanhamento longitudinal, o consentimento será reconfirmado em cada onda.

7.3 RISCOS E BENEFÍCIOS

A pesquisa é classificada como de risco baixo, de natureza psicossocial. Os riscos previstos e as respectivas medidas de mitigação são:

a) desconforto ao relatar conflitos, frustrações ou experiências de violência – mitigado pela liberdade de não responder e de interromper a entrevista e pelo encaminhamento à rede de atenção psicossocial quando necessário;

b) **coerção**, porque os pesquisadores populares são supervisionados pela equipe que implementa a metodologia e os profissionais têm vínculo com a SES-DF – mitigado pela realização das entrevistas por pesquisadores da UnB, sem relação hierárquica com os participantes, e pela garantia de que nenhuma informação individual será repassada ao CTIS ou à gestão;

c) exposição de conflitos locais e identificação de pessoas ou setores em publicações – mitigada pelo uso de pseudônimos, pela codificação dos setores (A a D) e pela supressão de detalhes que permitam reconhecer participantes;

d) exposição dos pesquisadores populares a conflitos decorrentes da articulação do Plano Popular – mitigada pela não divulgação de posicionamentos individuais e por análise de risco antes de qualquer publicação.

Os benefícios diretos são a participação nas oficinas de interpretação e o acesso aos resultados. Os benefícios coletivos são o conhecimento sobre as condições que fazem a vigilância popular produzir

resposta e as recomendações para o aprimoramento da metodologia e da articulação com os serviços. A participação não envolve custo nem remuneração; despesas de transporte e alimentação decorrentes da participação serão ressarcidas.

7.4 PROTEÇÃO DE DADOS

O tratamento de dados pessoais terá como base legal a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida a anonimização sempre que possível (art. 7º, inciso IV, e art. 11, inciso II, alínea "c", da Lei nº 13.709/2018) (BRASIL, 2018). Áudios e transcrições serão armazenados em servidor institucional com acesso restrito à equipe de campo; a chave que liga pseudônimos a identidades será guardada separadamente. A transcrição será feita pela equipe ou por serviço contratado sob termo de confidencialidade. Os registros da Plataforma Ágora serão acessados apenas de forma agregada ou desidentificada. Os dados serão mantidos por cinco anos após o término do estudo e então eliminados. Transcrições e dados brutos não serão publicados.

7.5 DEVOLUTIVA E GOVERNANÇA COMUNITÁRIA

Os resultados serão devolvidos a cada Sala de Cooperação Social em linguagem acessível, nas oficinas de interpretação e em uma devolutiva final, e às equipes de APS e à SES-DF em relatório técnico. As Salas serão consultadas sobre a forma de divulgação dos achados que envolvam o território, sem prejuízo das obrigações de proteção de dados e sem poder de veto sobre resultados científicos.

8 LIMITAÇÕES

a) **caso único**: os achados não se generalizam estatisticamente; sua transferência para outros territórios dependerá da descrição densa do contexto e da explicitação dos mecanismos;

b) **proximidade institucional**: mesmo com a separação de equipes, a vinculação da pesquisa à Fiocruz pode induzir respostas favoráveis; por isso a busca ativa de participantes críticos e afastados e a revisão externa;

c) **viés de atividade**: participantes mais ativos tendem a dominar entrevistas e reuniões; as entrevistas de saída e a inclusão de membros da rede que não se tornaram pesquisadores populares procuram corrigir esse viés;

d) **dependência do cronograma da intervenção**: atrasos na implantação deslocam as ondas e podem reduzir o tempo de observação dos últimos setores, o que será registrado e considerado na análise;

e) **efeito da própria pesquisa**: as oficinas de interpretação podem alterar a implementação; essas alterações serão documentadas e analisadas, e não ocultadas;

f) **percepção e efeito**: relatos de melhora são evidências sobre experiências e significados, e não comprovação de mudança nas condições de saúde.

9 RESULTADOS ESPERADOS E PRODUTOS

Os resultados esperados são produtos de conhecimento, e não garantias de eficácia da metodologia:

a) teoria do programa da metodologia revisada, com configurações contexto-mecanismo-resultado sustentadas por evidência empírica;

b) tipologia das trajetórias de alertas e demandas, com as condições associadas à resposta, à recusa e à ausência de resposta;

c) análise da constituição e da transformação das Salas de Cooperação Social como espaços de governança participativa;

d) recomendações à PICAPS, à SES-DF e às equipes de APS sobre a articulação entre Salas e serviços, cada uma rastreável às evidências que a sustentam;

e) protocolo de avaliação de processo, roteiros e guias de observação, disponíveis para reaplicação em outros territórios;

f) relatório técnico para a gestão, materiais de devolutiva em linguagem acessível e artigos científicos proporcionais ao material produzido.

10 CRONOGRAMA

O estudo terá duração de 36 meses, organizados em seis semestres (S1 a S6). As ondas acompanham os marcos da implantação em cada setor (Quadro 3).

Quadro 6 – Cronograma de execução por semestre

Atividade	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Pactuação institucional, guia da intervenção e teoria inicial do programa	X					
Elaboração e teste dos instrumentos; submissão e aprovação ética	X					
Seleção e preparação da equipe de campo	X					
Onda 1 (ativação e cartografia)		X	X			
Onda 2 (início da operação das Salas)			X	X		
Onda 3 (consolidação das Salas)				X	X	X
Observação das Salas e oficinas		X	X	X	X	X
Rastreamento de trajetórias			X	X	X	X
Análise iterativa e revisão da teoria do programa		X	X	X	X	X
Oficinas de interpretação				X	X	X
Relatório final, devolutiva final e artigos						X

Fonte: Elaboração própria (2026).

11 RECURSOS E ORÇAMENTO

O Quadro 7 apresenta as rubricas e as quantidades estimadas. Os valores serão definidos conforme a fonte de financiamento e deverão constar do formulário da Plataforma Brasil.

Quadro 7 – Orçamento estimado

Rubrica	Especificação e quantidade estimada	Valor (R$)
Bolsas de pesquisa	Dois pesquisadores de campo (UnB) por 30 meses; um bolsista de apoio por 24 meses	[a preencher]
Transcrição	Cerca de 100 entrevistas de aproximadamente 60 minutos	[a preencher]
Software e equipamentos	Licença MAXQDA para a equipe; gravadores digitais; armazenamento institucional seguro	[a preencher]
Deslocamento	Transporte da equipe ao território durante 27 meses de campo	[a preencher]
Ressarcimento de participantes	Transporte e alimentação para entrevistas e oito oficinas de interpretação	[a preencher]
Revisão externa	Analista independente para revisão da trilha de auditoria em três momentos	[a preencher]
Divulgação	Materiais de devolutiva e publicação em acesso aberto	[a preencher]
Total	Fonte de financiamento: [a preencher]	[a preencher]

Fonte: Elaboração própria (2026).

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 18055, 20 set. 1990.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024. Dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 29 maio 2024.

BRASIL. Decreto nº 12.651, de 7 de outubro de 2025. Regulamenta a Lei nº 14.874, de 28 de maio de 2024. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 3, 8 out. 2025.

BREILH, J. **Epidemiologia crítica**: ciência emancipadora e interculturalidade. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis**: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007.

CALLON, M. Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In: LAW, J. (ed.). **Power, action and belief**: a new sociology of knowledge? London: Routledge, 1986. p. 196-223.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 13 jun. 2013.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 24 maio 2016.

FALS BORDA, O. **Conocimiento y poder popular**: lecciones con campesinos de Nicaragua, México y Colombia. Bogotá: Punta de Lanza; Siglo XXI, 1985.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Manual técnico-operacional de diagnóstico situacional para territórios**: Diálogos Prospectivos Territoriais (DPT). Brasília: Fiocruz Brasília/PICAPS, 2026a.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Protocolo de Inteligência Territorial**. Brasília: Fiocruz Brasília/CoLaboratório CTIS/PICAPS, 2026b.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Diagnóstico situacional do Distrito Federal**. Brasília: Fiocruz Brasília/CoLaboratório CTIS, 2026c. (Série Diagnósticos Territoriais – PICAPS).

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FUNTOWICZ, S. O.; RAVETZ, J. R. Science for the post-normal age. **Futures**, v. 25, n. 7, p. 739-755, 1993.

GALE, N. K. et al. Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. **BMC Medical Research Methodology**, v. 13, art. 117, 2013.

GRANOVETTER, M. The strength of weak ties. **American Journal of Sociology**, v. 78, n. 6, p. 1360-1380, 1973.

GROSSOEHME, D.; LIPSTEIN, E. Analyzing longitudinal qualitative data: the application of trajectory and recurrent cross-sectional approaches. **BMC Research Notes**, v. 9, art. 136, 2016.

HOFFMANN, T. C. et al. Better reporting of interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and guide. **BMJ**, v. 348, g1687, 2014.

LAURELL, A. C. La salud-enfermedad como proceso social. **Revista Latinoamericana de Salud**, México, v. 2, p. 7-25, 1982.

LINCOLN, Y. S.; GUBA, E. G. **Naturalistic inquiry**. Beverly Hills: Sage, 1985.

MACHADO, J. M. H. et al. Vigilância popular em saúde: conceitos, experiências e desafios no contexto brasileiro. **Interface**: Comunicação, Saúde, Educação, v. 28, e240304, 2024.

MALTERUD, K.; SIERSMA, V. D.; GUASSORA, A. D. Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. **Qualitative Health Research**, v. 26, n. 13, p. 1753-1760, 2016.

MARTINS, W. J. et al. Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS): soluções tecnocientíficas em saúde digital no enfrentamento da COVID-19 e outras crises. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 10, e01622023, 2024.

MATUS, C. **Política, planificación y gobierno**. Washington, DC: OPS/OMS, 1987.

MOORE, G. F. et al. Process evaluation of complex interventions: Medical Research Council guidance. **BMJ**, v. 350, h1258, 2015.

NEALE, B. **What is qualitative longitudinal research?** London: Bloomsbury Academic, 2019.

O'BRIEN, B. C. et al. Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. **Academic Medicine**, v. 89, n. 9, p. 1245-1251, 2014.

OLIVEIRA, S. S. et al. Vigilância popular em saúde: conceitos, experiências e potencialidades. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 5, 2024.

PAIM, J. S. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, 2018.

PAWSON, R.; TILLEY, N. **Realistic evaluation**. London: Sage, 1997.

SALDAÑA, J. **Longitudinal qualitative research**: analyzing change through time. Walnut Creek: AltaMira Press, 2003.

SANTOS, M. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2002.

SELLERA, P. E. G. et al. A ativação de redes sociotécnicas na Cidade Estrutural/DF: um território saudável e sustentável. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 9, p. 3423-3434, 2019.

SKIVINGTON, K. et al. A new framework for developing and evaluating complex interventions: update of Medical Research Council guidance. **BMJ**, v. 374, n2061, 2021.

STAR, S. L.; GRIESEMER, J. R. Institutional ecology, 'translations' and boundary objects: amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. **Social Studies of Science**, v. 19, n. 3, p. 387-420, 1989.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 2011.

TONG, A.; SAINSBURY, P.; CRAIG, J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. **International Journal for Quality in Health Care**, v. 19, n. 6, p. 349-357, 2007.

TRAD, L. A. B.; ESPERIDIÃO, M. A. Gestão participativa e corresponsabilidade em saúde: limites e possibilidades no âmbito da Estratégia de Saúde da Família. **Interface**: Comunicação, Saúde, Educação, v. 13, n. 31, p. 557-570, 2009.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

APÊNDICE A – ROTEIRO-BASE DE ENTREVISTA COM PESQUISADORES POPULARES

O roteiro abaixo é a versão-base para o painel de pesquisadores populares. Roteiros específicos para os demais grupos seguem a mesma estrutura e serão testados na Fase 1. Em cada onda, o entrevistador retoma o que o participante relatou na onda anterior.

Onda 1 – ativação e cartografia

a) como você conheceu a PICAPS e o que o levou a participar;

b) quem mais participou das primeiras reuniões, e quem você esperava ver e não estava;

c) conte uma situação da cartografia social em que um problema do território foi discutido: o que foi dito, quem falou, o que foi decidido;

d) o que você espera que mude no território com esse processo.

Onda 2 – início da Sala de Cooperação Social

a) como foi a formação para você: o que fez sentido e o que não fez;

b) conte o último alerta ou demanda que você registrou: o que aconteceu depois;

c) como as decisões são tomadas nas reuniões da Sala, e quem tem mais influência;

d) como os profissionais da UBS têm recebido o que vocês levam.

Onda 3 – consolidação

a) o que mudou na sua atuação e na Sala desde a nossa última conversa;

b) conte um caso que avançou e um caso que não avançou: o que explica a diferença;

c) o que custa para você participar, em tempo, dinheiro, relações e riscos;

d) se a Sala deixasse de existir amanhã, o que se perderia, e o que continuaria.

APÊNDICE B – GUIA DE OBSERVAÇÃO DAS REUNIÕES DAS SALAS DE COOPERAÇÃO SOCIAL

O diário de campo de cada reunião registra, em seções separadas, a descrição dos fatos e a interpretação do pesquisador.

a) **contexto**: data, local, duração, número e perfil dos presentes (sem identificação nominal), presença de profissionais de APS e de vigilância;

b) **pauta e encaminhamentos**: temas tratados, origem de cada tema (alerta, Plano Popular, demanda externa), decisões tomadas e responsáveis;

c) **dinâmica deliberativa**: quem propõe, quem contesta, quem decide; temas encerrados sem deliberação; uso de dados, mapas ou do painel territorial;

d) **relação com os serviços**: retornos recebidos sobre encaminhamentos anteriores, ausência de retorno, reações do grupo;

e) **reflexividade**: impressões, desconfortos e possíveis efeitos da presença do pesquisador.

APÊNDICE C – FICHA DE RASTREAMENTO DE TRAJETÓRIA

Cada episódio rastreado (alerta da vigilância popular ou demanda do Plano Popular) é registrado nesta ficha, preenchida a partir de documentos e de entrevistas curtas com os atores envolvidos.

a) **identificação**: código do episódio, setor, tipo (alerta ou demanda), data do registro inicial;

b) **origem**: como o problema foi percebido, por quem e com que categorias foi descrito;

c) **percurso**: cada passagem entre atores (pesquisador popular, Sala, UBS, vigilância, gestão), com data, forma de comunicação e tradução realizada;

d) **desfecho**: resposta, recusa, reclassificação ou ausência de resposta, com data e justificativa apresentada;

e) **interpretação**: condições que explicam o desfecho, segundo cada ator e segundo a análise da equipe, e configuração contexto–mecanismo–resultado associada.